SDD 12 Sujet n°1

Spécialité : Médecine d'urgence / Gériatrie

Date : 14/09/2023
Auteur : Pierre-Adrien Lachaud (DES Anesthésie-Réanimation - ECN 2023)
Relecteur(s) : Sébastien Villard (DES de Médecine interne - ECN 2023), Eloïse Francq (DES de gériatrie - ECN 2020), Clara Couchoud (DES de gériatrie - ECN 2023)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie pertinente de la prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Synthèse des résultats d'examens paracliniques
Item(s) en lien avec la station	109 - Troubles de la marche et de l'équilibre. 120 - Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge. 131 - Troubles de la marche et de l'équilibre (particularités chez la personne âgée). 133 - Autonomie et dépendance chez le sujet âgé. 154 - Infections broncho pulmonaires communautaires de l'adulte et de l'enfant. 348 - Insuffisance rénale aiguë. Anurie.
Situation(s) de départ en lien avec la station	012 - Station au sol prolongée
Matériel nécessaire à la station	3 chaises - 1 table Papiers - stylos - iPad pour examinateurs
Contexte de la station	Arrivée d'un patient âgé au SAU dans un contexte de chute avec station au sol prolongée. L'étudiant doit expliquer les principales complications en fonction de la vignette clinique et comment prendre en charge ces dernières.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDATE

Contexte :
Vous êtes interne dans un service d'urgence et vous recevez, à 10h30, M. Manard âgé de 82 ans amené par une ambulance pour chute à son domicile.
Le patient a été retrouvé au sol par son infirmière à domicile autour de 9h30, conscient mais dans l'incapacité de se relever. Il aurait chuté au cours de la nuit (sans se rappeler de l'heure) en voulant aller uriner, en s'entravant dans son tapis.

Le patient a comme principaux antécédents :
- Cataracte bilatérale opérée il y a 3 ans
- Hypertension artérielle essentielle traitée par bithérapie (Telmisartan / Hydrochlorothiazide).

A son arrivée, l'infirmier d'accueil a relevé les constantes suivantes :
- Fréquence cardiaque : 110/min
- Fréquence respiratoire : 24/min
- Saturation pulsée en oxygène : 95% en air ambiant
- Tension artérielle : 105/62mmHg
- Température : 38,5°C

L'observation de l'externe note dans l'examen clinique les éléments suivants :
- Crépitants auscultatoires en base pulmonaire droite
- Rougeur au niveau du talon droit et du sacrum
- Langue sèche, face interne des joues sèches
- Douleur et oedème important du mollet droit, unilatéral, avec signe de Homans positif

La biologie du patient est disponible en annexe. La créatinine 2 semaines auparavant était de 102 mmol/L.

ECG : rythme sinusal régulier, 110/min, axe droit, bloc de branche droit connu, pas d'autre trouble de la conduction, pas de signe d'ischémie.

Consignes :
Vous devez, en 7 minutes indiquez à votre collègue/examinateur :
- Les complications somatiques que vous pouvez évoquer
- La prise en charge initiale **aux urgences** de ces complications

Vous ne devez pas :
- Détailler les complications psychologiques liées à la station prolongée au sol
- Expliquer la prise en charge sociale, rééducative et la prévention du syndrome de désadaptation psychomotrice
- Réaliser le bilan étiologique post-chute

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

L'étudiant peut répondre aux 2 questions en même temps en indiquant une complications et la prise en charge attendue par la suite. Cela n'est pas pénalisable.

Aptitudes cliniques			
Complications somatiques dans le cadre de la station prolongée au sol			
1.	Complication métabolique : insuffisance rénale aiguë	1 pt	☐
2.	Complication métabolique : rhabdomyolyse	1 pt	☐
3.	Complication métabolique : hyperkaliémie	1 pt	☐
4.	Complication métabolique : déshydratation	1 pt	☐
5.	Complication cutanée : escarres cutanées / point de compression	1 pt	☐
6.	Complication thrombotique : maladie thrombo-embolique veineuse (TVP, EP)	1 pt	☐
7.	Complication infectieuse : pneumopathie d'inhalation	1 pt	☐
Prise en charge			
8.	Suspension du traitement antihypertenseur (ARA2)	1 pt	☐
9.	Réalisation d'une imagerie des voies urinaires dans le cadre du bilan d'insuffisance rénale aiguë	1 pt	☐
10.	Demande d'une échographie-doppler du MI pour recherche d'une TVP	1 pt	☐
11.	Réalisation d'une radiographie pulmonaire	1 pt	☐
12.	Mise en place d'une hydratation par un soluté isotonique	1 pt	☐
13.	Mise en place de soins de nursing sur les points de compression ET prévention des escarres cutanées	1 pt	☐
14.	Mise en place d'un antipyrétique et antalgique : PARACÉTAMOL	1 pt	☐
Communications et attitudes			

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

8. APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'arrive pas à faire ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème quelquefois sans les justifier	Fait ressortir les éléments nécessaires pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Fait ressortir les éléments positifs et négatifs pour clarifier le problème et justifie son raisonnement	Agit avec assurance et sans erreur

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL (max 20 items)	/ 19 points

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Devant cette station il faut être très systématique, en réfléchissant organes par organes et ne pas oublier des éléments basiques comme l'hypothermie (ce qui n'est pas le cas ici en raison de la pneumopathie d'inhalation).

Il est important dans le cadre de chaque complication de bien justifier comment la rechercher, la prévenir et/ou la traiter. Cela nécessite une bonne transversalité.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Il est inadmissible de ne pas évoquer la rhabdomyolyse et les 2 conséquences graves qui en découlent (insuffisance rénale aiguë, hyperkaliémie) et qui sont présentes dans cette station.

A noter que, d'après le LiSA, la réalisation d'un ECG est quasi-systématique pour le bilan étiologique. Dans le cadre du bilan des complications, il sera réalisé si l'on a une suspicion d'hyperkaliémie avant le résultat du ionogramme et systématiquement en cas d'hyperkaliémie prouvée au ionogramme.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

1 table avec 3 chaises : 1 pour l'étudiant et 2 en face pour les examinateurs

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Document avec les instructions pour le candidat disponible dans la salle d'évaluation à proximité du candidat

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)